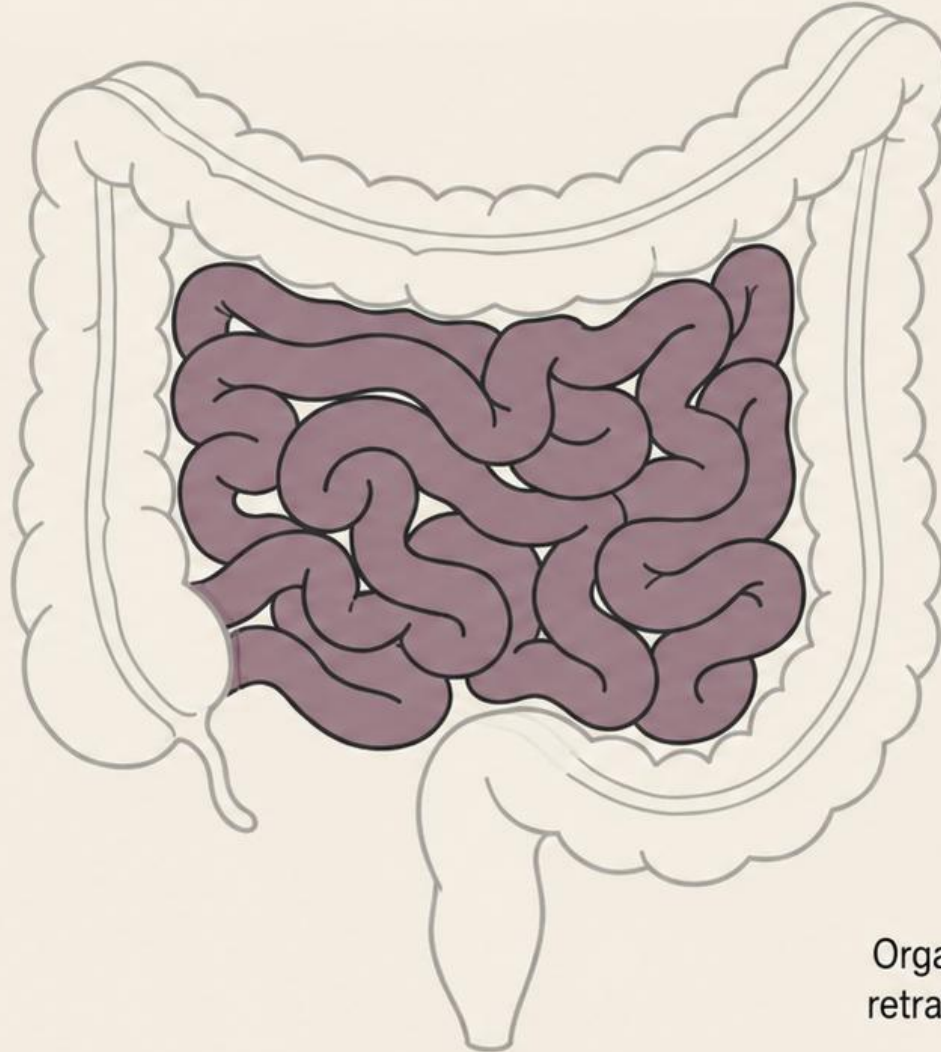


L'Intestino Crasso: Anatomia, Ecosistema e Approccio ROP

Capitolo 14 — L'incrocio sistemico, meccanico, neurologico e immunitario.

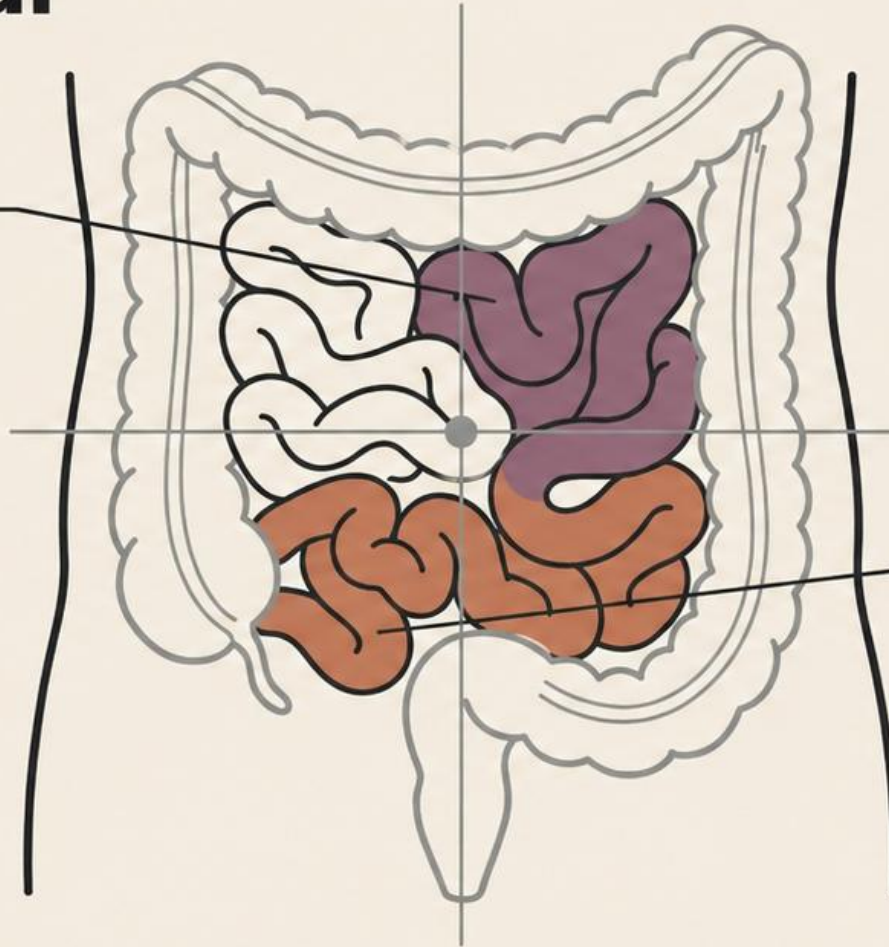


Organo più lungo del corpo (6-7 metri post-mortem, retratto in vivo per il tono muscolare), che si estende dal piloro alla valvola ileo-cecale.

Topografía y disposición intraabdominal

Yeyuno

- Cuadrante superior izquierdo
- Cubre el colon descendente
- Orientaciones vasculares y asas mayoritariamente horizontales

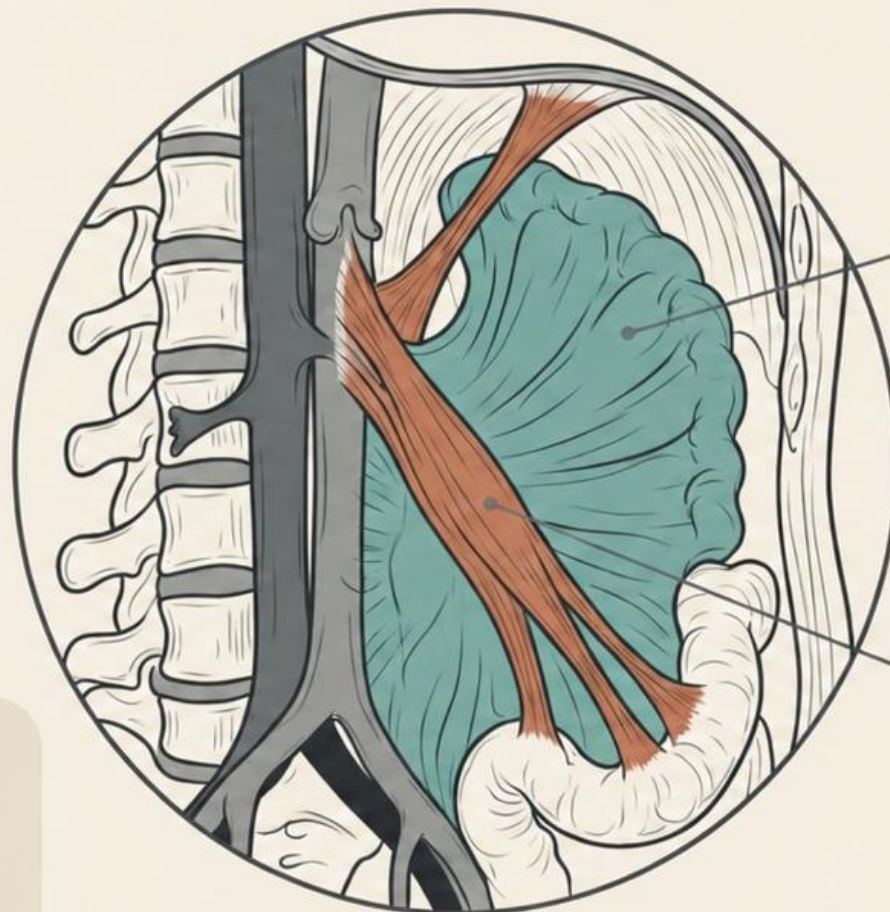


Íleon

- Cuadrante inferior derecho
- Deja libre el colon ascendente
- Orientaciones vasculares y asas mayoritariamente verticales

Longitud cadavérica: 6 a 7 metros. Diámetro: 2 a 3 cm.
Órgano intra-peritoneal extremadamente móvil.

L'Ancrage Mécanique : Mésentère et Muscle de Treitz



• Radice del mesentere

Linea di attacco di 16–18 cm, che attraversa l'ombelico nei livelli L3–L4. Garantisce stabilità e trasporto di vasi e nervi.

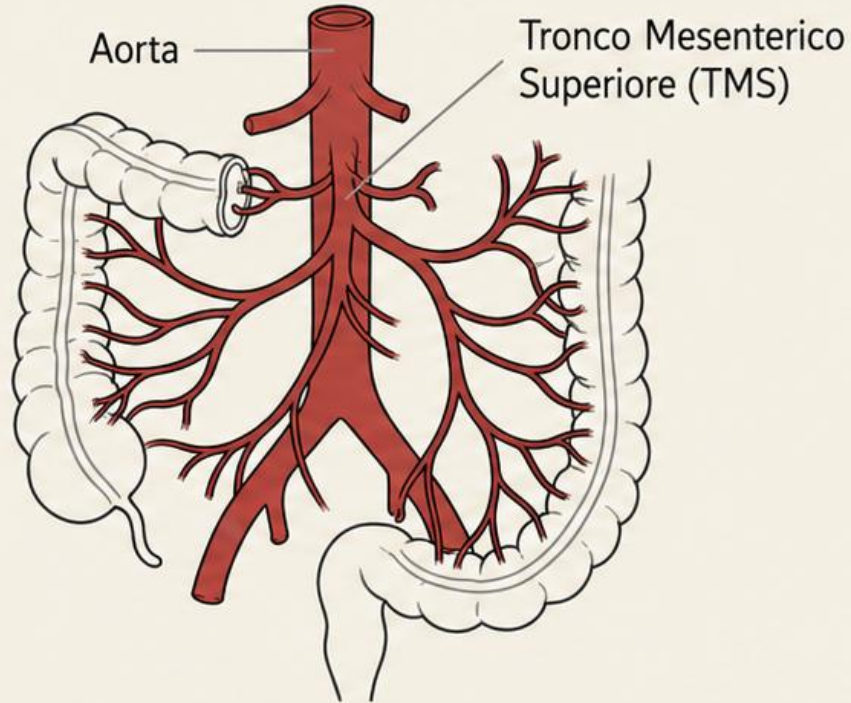
• Muscolo di Treitz

Si inserisce sul pilastro destro del diaframma. Mantiene l'angolo duodeno-digiunale e assicura la tensione longitudinale.

Sindrome della Pinza Aorto-Mesenterica (Sindrome ROP)

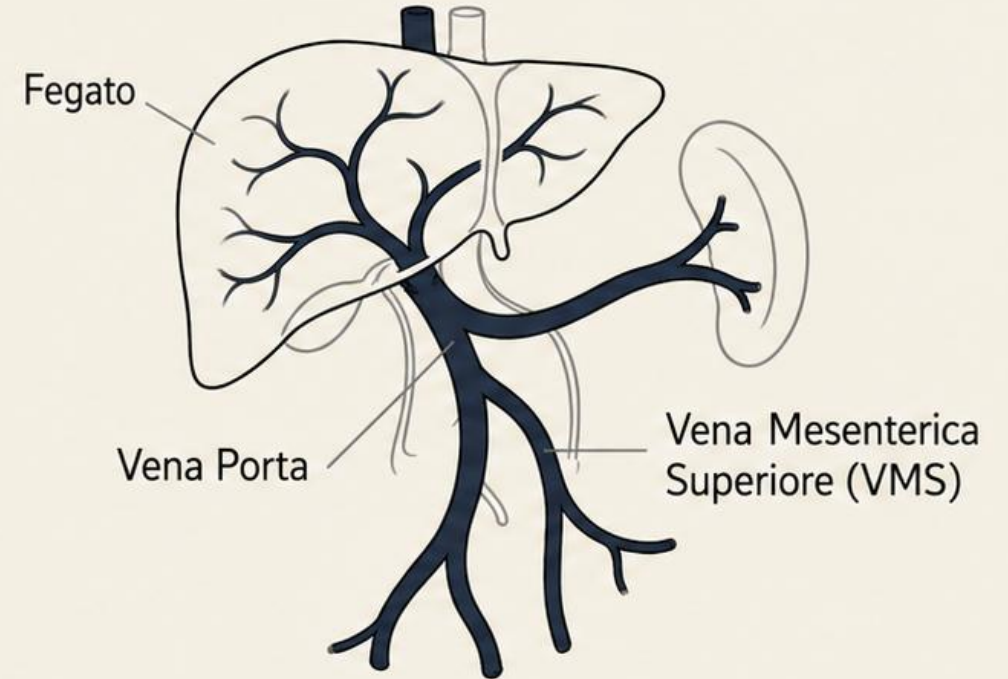
Una perdita di tensione longitudinale può causare una compressione della 4^a porzione duodenale (sindrome del nutcracker), rallentando lo svuotamento e favorendo il reflusso gastro-duodenale.

L'asse dell'irrigazione e del drenaggio: Tronco Mesenterico Superiore



Apporto Arterioso (Arteria Mesenterica Superiore)

- Origine: Disco Th12-L1 (sotto il tronco celiaco)
- Irriga l'intestino tenue, il colon ascendente e i 2/3 prossimali del trasverso



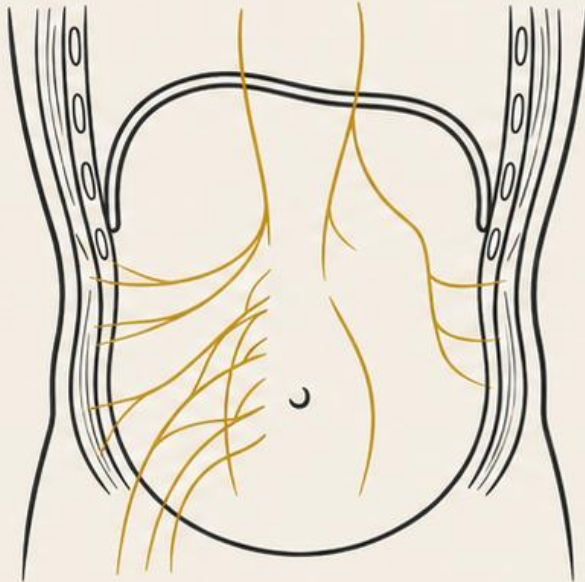
Drenaggio Venoso (Sistema Portale)

- Trasporta il sangue venoso carico di nutrienti assorbiti direttamente al fegato per disintossicazione e metabolismo.

Nota Pratica: Il polso del TMS è percepibile a livello della 3^a porzione del duodeno, a destra dell'ombelico.

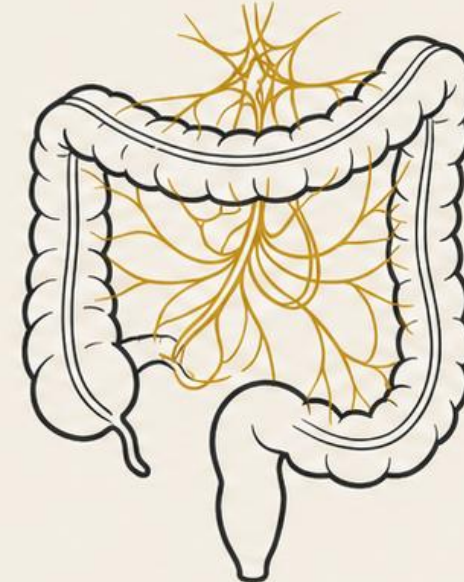
La doppia realtà neurologica del peritoneo

Peritoneo Parietale (Innervazione Somatica)



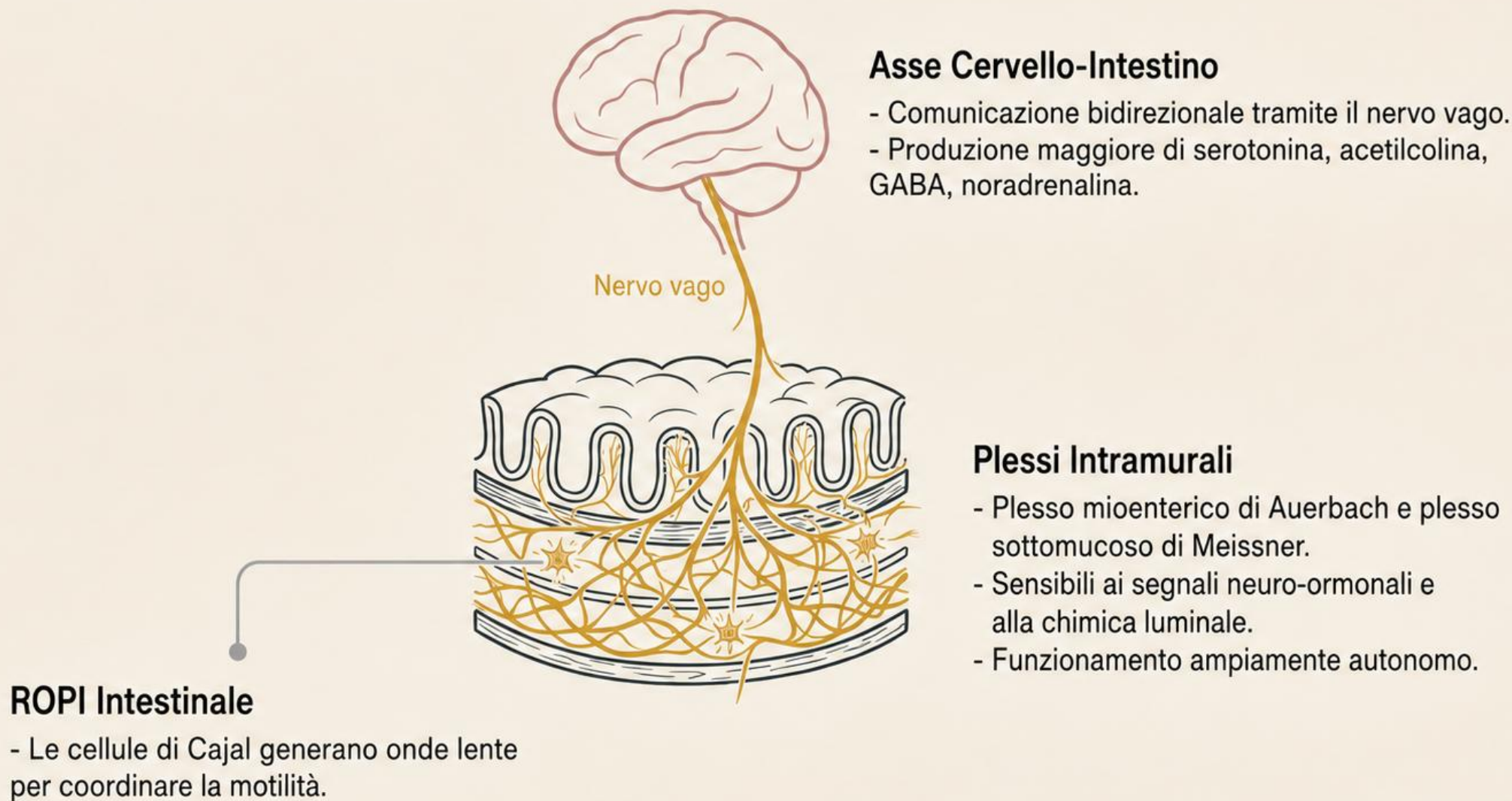
- Vie: Nervi phrenici, sei ultimi nervi intercostali, plesso lombare.
- Sensibilità: Acuta (dolore, pressione, temperatura).
- Implicazione ROP: Proiezione dei dolori peritoneali al sistema osteo-muscolo-articolare (cervicali, lombari, scapolari).

Peritoneo Viscerale (Innervazione Autonoma)



- Vie: Sistema Simpatico (Th8-Th11, nervi splancnici) e Parasimpatico (Nervo Vago).
- Sensibilità: Debole al tocco/sezione. Stimolata da stiramento (distensione) e da sostanze chimiche.
- Implicazione ROP: Il Simpatico inibisce il peristaltismo (stress); il Vago lo favorisce.

Il Secondo Cervello: Autonomia del Sistema Nervoso Enterico (SNE)



Il "Secondo Cervello": Sistema Nervoso Enterico

Plesso Intramurale

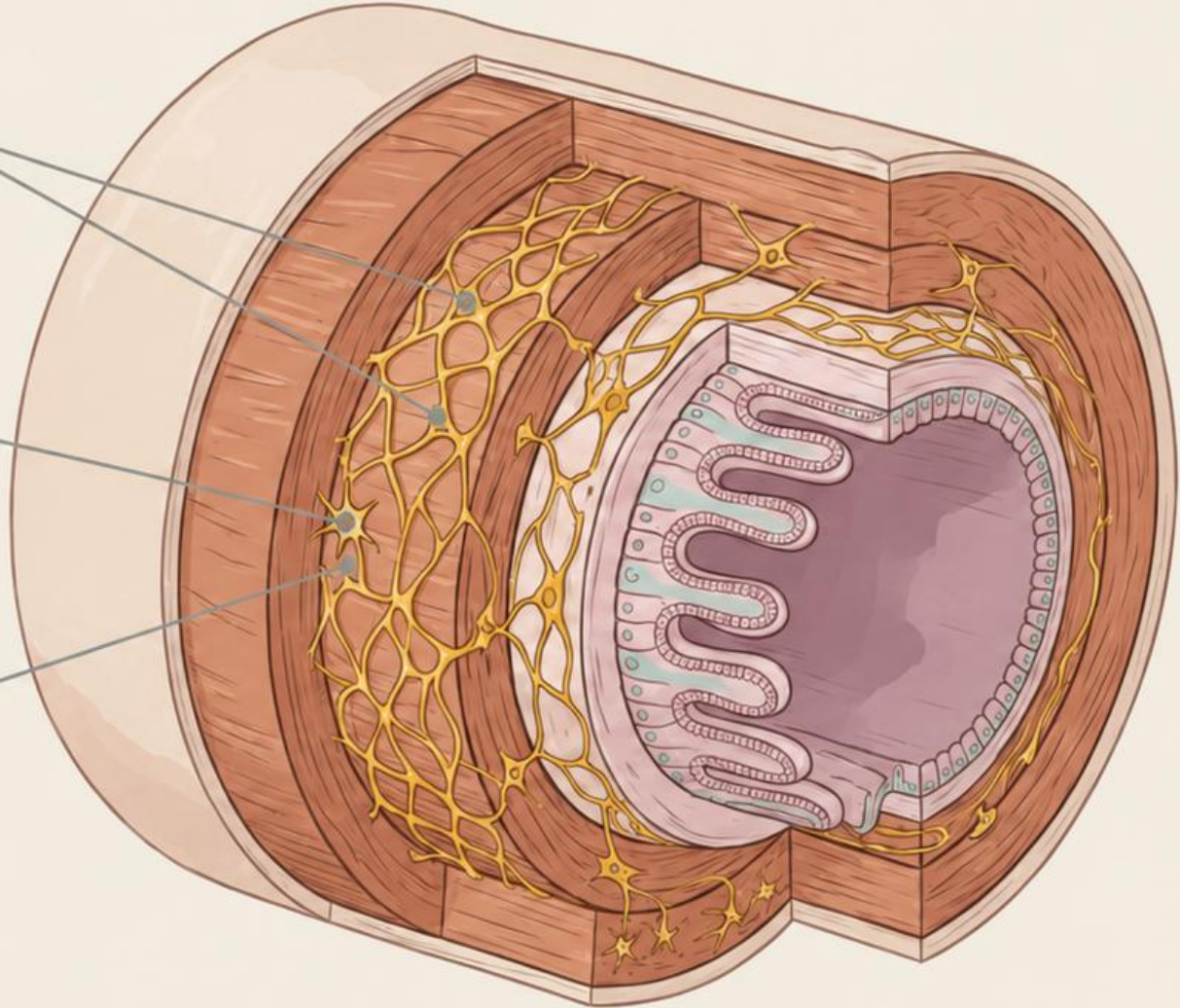
Plesso mienterico di Auerbach e plesso sottomucoso di Meissner. Assicurano una regolazione quasi autonoma delle funzioni digestive.

Cellule di Cajal

Il pacemaker intestinale. Generano onde lente che coordinano la motilità indipendentemente dal peristaltismo indotto dal chimo.

Produzione Neurochimica

Sintesi principale di serotonina (regolazione dell'umore condivisa con il cervello), acetilcolina, noradrenalina e GABA.



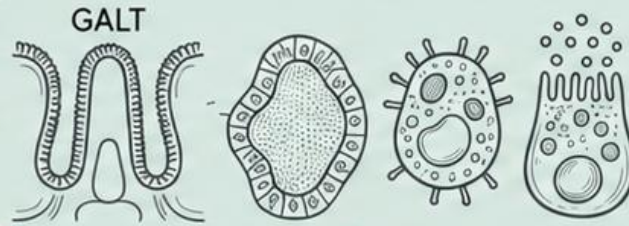
L'Ecosistema intestinale:

Il pilastro della salute digestiva



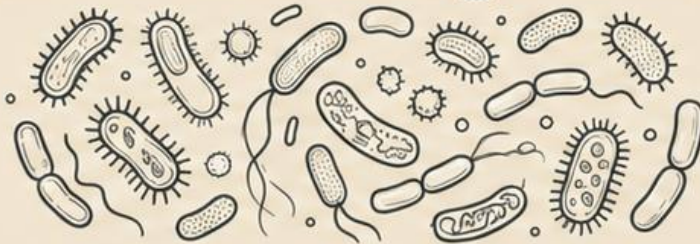
1. Mucosa Intestinale (Interfaccia)

- Enterociti con desmosomi (giunzioni strette).
- Cellule caliciformi (produzione di muco protettivo).



2. Sistema Immunitario (Difesa)

- GALT (Gut Associated Lymphoid Tissue) e Placche di Peyer.
- Mastociti e Cellule di Paneth (peptidi antimicrobici).



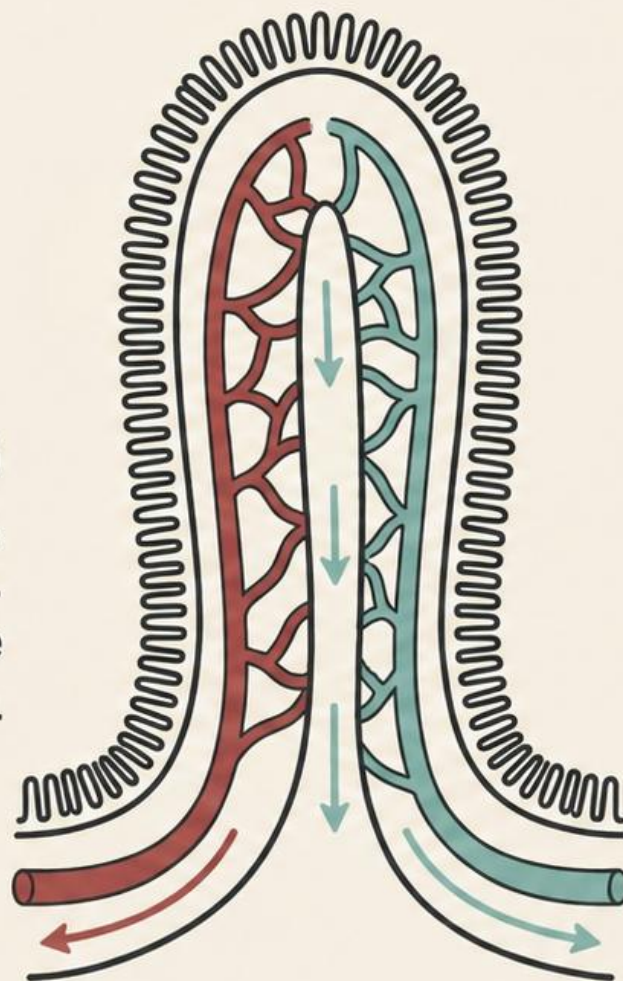
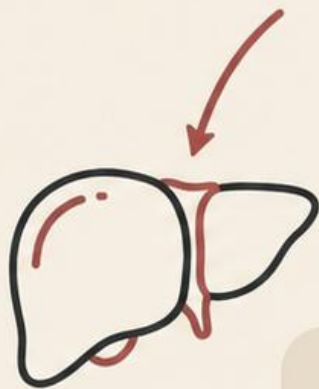
3. Microbiota (Simbiosi)

- ~38 miliardi di batteri per organismo.
- Impronta unica dalla nascita. Contribuisce all'immunità, alla digestione e all'asse intestino-cervello.

La Doppia Via di Assorbimento Micronutrizionale

Via Sanguigna (Capillari)

- Assorbiti: Acqua, zuccheri semplici, amminoacidi, vitamine idrosolubili.
- Destinazione: Trasportati direttamente al fegato attraverso la vena porta.



Via Linfatica (Chiliferi)

- Assorbiti: Grassi, proteine a catena lunga, vitamine liposolubili (A, D, E, K).
- Destinazione: Rete linfatica -> Cisterna del Pecquet -> Dotto toracico.



Interesse in ROP: un'azione riflessa podale su fegato e sistema linfatico sostiene qualitativamente l'assorbimento e l'immunità.

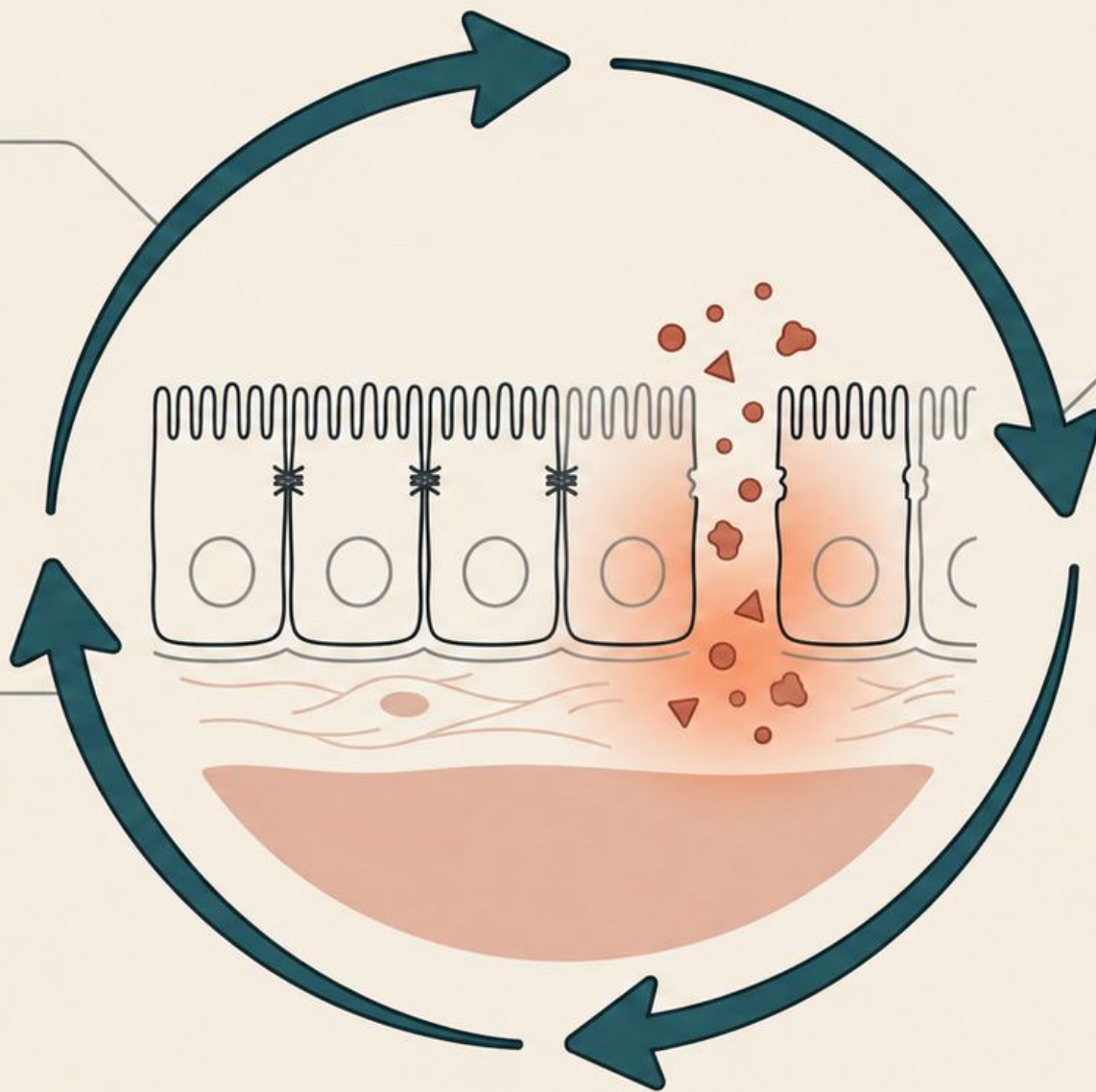
La Spirale : Disbiosi e Iperpermeabilità

Fattori scatenanti

Stress cronico
(vasocostrizione simpatica),
alimenti ultra-processati,
FANS, antibiotici.

Iperpermeabilità

Alterazione delle giunzioni
strette. Passaggio di tossine
e proteine non completamente
degradate, innescando
l'infiammazione.



Conseguenze Sistemiche

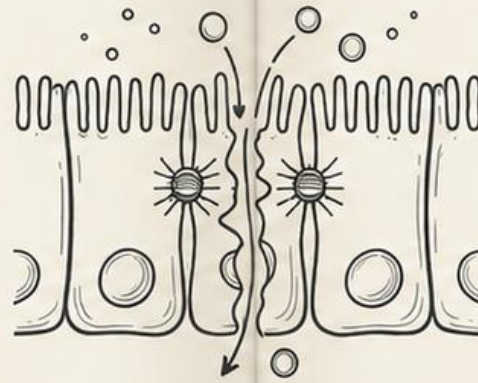
Sovraccarico epatico
(teoria di ROP). Il fegato
satturo reindirizza i rifiuti
verso i tessuti, causando
dolori articolari, tendiniti
e allergie.

Patologia I : Aumentata permeabilità intestinale (Leaky Gut)

Cause (Aggressioni)

- Stress cronico
(vasocostrizione mediata dal sistema simpatico)
- FANS / Antibiotici
- Alimentazione ultra-trasformata
- Sport di resistenza estremi

Meccanismo (Rottura)



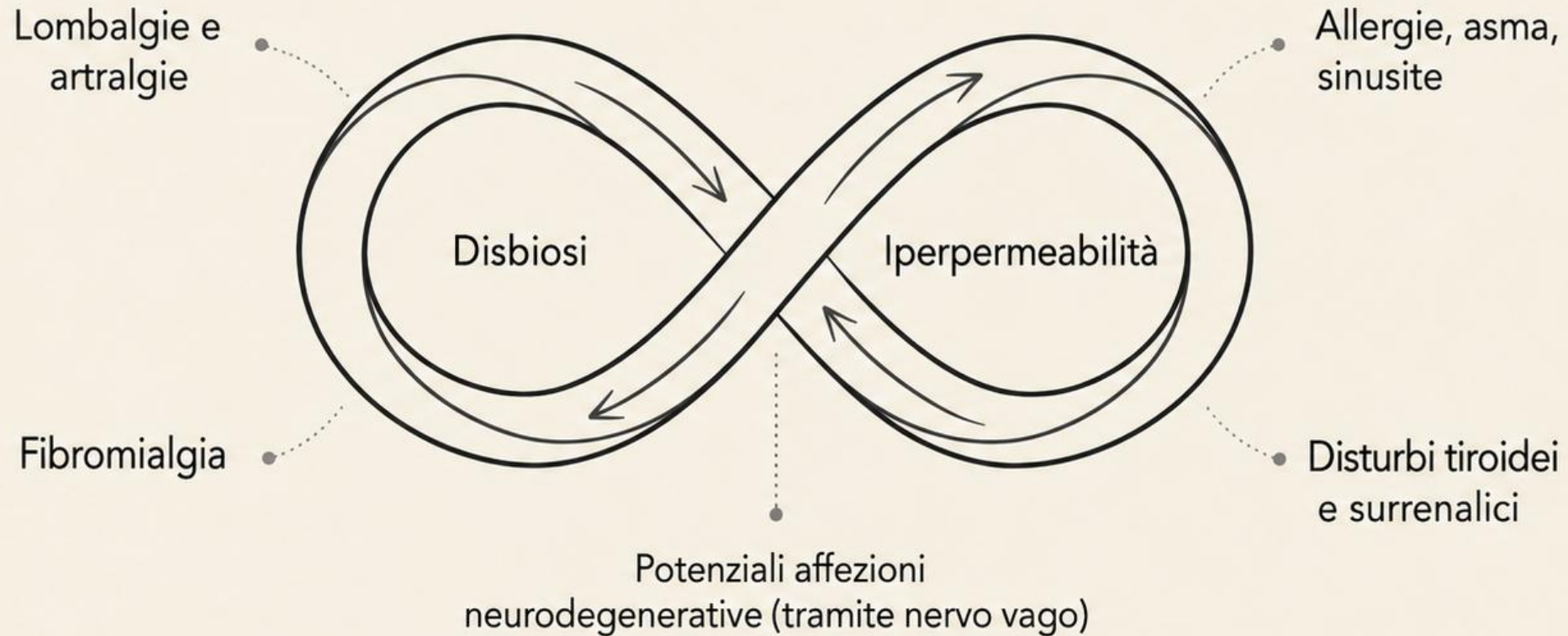
Alterazione delle giunzioni intercellulari → Passaggio di macromolecole → infiammazione sistemica.

Conseguenze (Sistemiche)

- Attivazione del sistema immunitario (allergie, malattie autoimmuni).
- Sovraccarico epatico (Teoria del sovraccarico del Dr. Seignalet: deposito di tossine nei muscoli, articolazioni, cervello).

Interesse ROP : Di fronte a dolori osteoarticolari senza trauma evidente, considerare sempre un legame con una disfunzione viscerale.

Patologia II: La Disbiosi e le sue manifestazioni



Sintomi annunciatori: Meteorismo, aerocolia, alternanza diarrea/stitichezza, pirosi, attrazione anomala per zuccheri/carni crude, alitosi carica.

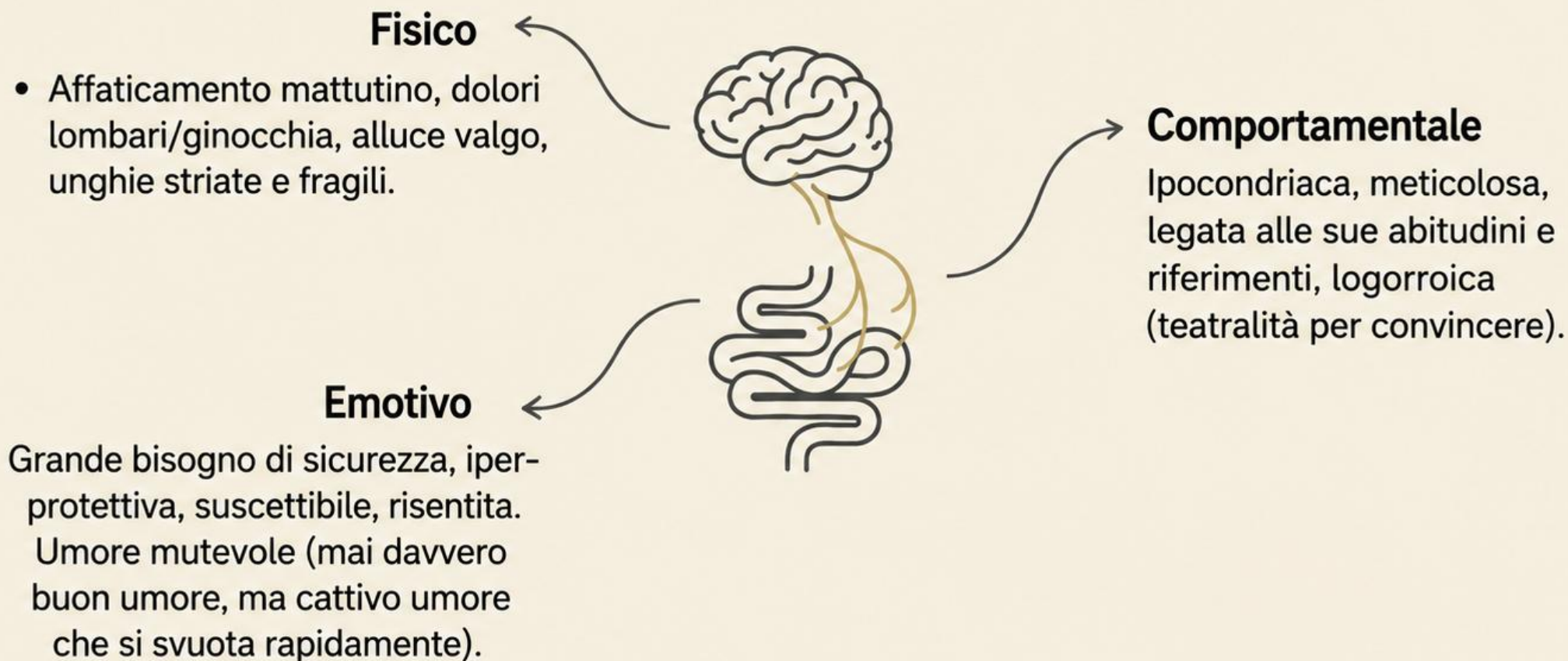
Nota: Correlazione $\neq$ Causalità (ROP): i due disturbi coesistono e si influenzano reciprocamente.

Segni di Allarme e Diagnosi di Esclusione

Orientamento Medico Imperativo in presenza di:

- - Febbre, sangue rosso o nero nelle feci.
- - Perdita di peso significativa e inspiegata.
- - ROP del Treitz (giunzione giugulo-succlavia sinistra): sospetto oncologico.
- - Segno della scodella: suggestivo di ascite.
- - Ernia inguinale strangolata irriducibile.
- - Occlusione / ileo: arresto di feci e gas. Può essere meccanico (tumore, ernia strozzata) o paralitico (atonia da irritazione peritoneale).

Profilo viscerale-emotivo: La Persona con ROP



Nota: Molto dipendente dagli ormoni (soprattutto nelle donne). L'intestino crasso è il recettore-emettitore privilegiato delle tensioni emotive, favorendo l'iperattività simpatica.

Strategia ROP 1: Regolazione del Sistema Nervoso e dei Legami Somatici



Relazioni Viscerali-Somatiche

- Fissazioni vertebrali target: Th10 a Th12 (e coste associate), L1 e L2.



Zone Riflesse Podaliche – Sindrome di Adattamento

- Nervo Vago: territorio cranico, cervicale e addominale (iato esofageo, cuore).
- Sistema Simpatico: Catena gangliare latero-vertebrale (Th8–Th10) e pilastri del diaframma.
- Plesso Solare (Celiaco) e Plessi Lombari.
- Attivazione del Sistema Limbico: Tecnica di bilanciamento Cervello Limbico-Intestino per regolare l'asse viscerale-emotivo.

Accompagnamento ROP delle Patologie Funzionali



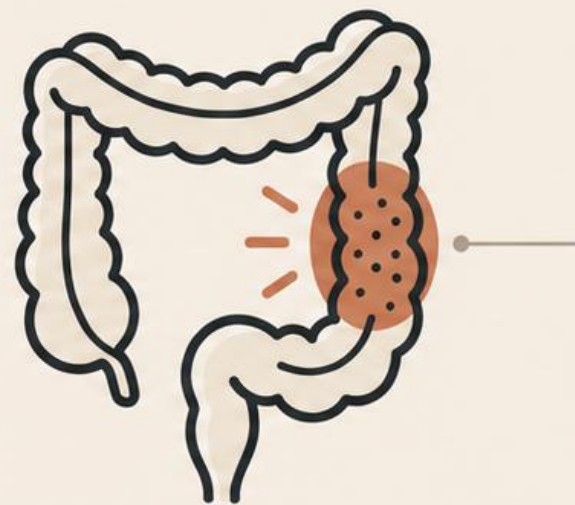
Enteroptosi

La massa enterica attratta verso il basso provoca stasi venose/linfatiche, spasmi nervosi e pressione sulla vescica (fughe urinarie). L'azione ROP ha come obiettivo ripristinare la tensione della radice mesenterica.



Ileo Paralitico

Inibizione della motilità da attivazione simpatica predominante (post-chirurgia, shock, ipokaliemia). Senza dolori da distensione. L'induzione mira a riattivare la Vaga.



Malattia di Crohn

Componenti genetiche, disbiotiche ed emozionali. L'approccio ROP contribuisce ad alleviare i dolori addomino-pelvici e a favorire un transito intestinale migliore.

Sintesi dell'Intervento ROP: Protocollo Intestino Crasso

Passo 1: Ascolto e Induzione (Sistema Limbico)

Azione: Un pollice sulla zona Intestino Crasso, l'altro sulla zona Cervello Limbico.

Obiettivo: Calmare il carico viscerο-emozionale (stress, ansia, bisogno di sicurezza) e rilanciare il tono vagale.



Passo 2: Liberazione Strutturale (Relazioni Viscerosomatiche)

Azione: Trattamento delle fissazioni vertebrali e costali.

Zone obiettivo: Cerniera T10-T12 (Simpatica) e L1-L2 (Plesso lombare, radice del mesentere).



Passo 3: Trattamento Locoregionale (Viscerale)

Azione: Rilascio delle tensioni del sistema di sospensione e stimolazione del peristaltismo.

Zone obiettivo: Diaframma (Treitz), Stomaco (riflesso), Radice del mesentere (tensione longitudinale) e cartografia digiuno/ileo.

L'approccio ROP ripristina la mobilità, l'innervazione e l'ecosistema: una risposta globale al massimo. Ogni malattia inizia nell'intestino.